ПРОДУКТОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цифровые решения для диагностики и ведения пациентов с тревогой и депрессией

Концепция платформы MindPath

Роли и функционал • Web / Android / iOS • Аналоги и внедрения • GitHub • MVP • Архитектура • Безопасность

Материал для обсуждения продуктовой идеи, планирования MVP и подготовки проектной документации.

Октябрь 2026

Важно: концепция носит исследовательский характер. Опросники и цифровые рекомендации не заменяют клиническое обследование и заключение специалиста.

Содержание

1. Концепция продукта 3

2. Пользовательские роли 4

3. Пользовательский путь и ключевой сценарий 6

4. Аналоги: зарубежные клинические платформы 6

5. Аналоги: пользовательские мобильные приложения 7

6. Аналоги: российский рынок 8

7. Открытые проекты GitHub 9

8. MVP и дорожная карта 10

9. Техническая архитектура 11

10. Клинические, правовые и этические требования 12

11. Бизнес-модель, метрики и проверка гипотез 12

12. Итоговая рекомендация 13

Приложение. Основные ссылки и материалы 14

В документе отделены уже существующие продукты и их заявленный функционал от предлагаемых возможностей MindPath. Для внешних решений указаны сайт, мобильные магазины и/или репозитории.

1. Концепция продукта

1.1. Рабочее название и позиционирование

MindPath — цифровая B2B2C-платформа для первичного скрининга симптомов тревоги и депрессии, планового наблюдения и сопровождения пациента между консультациями. Основные интерфейсы: мобильное приложение пациента (Android / iOS) и Web-кабинет специалиста. Для небольших организаций предусматривается Web-доступ пациента без обязательной установки приложения.

Принцип: пользователь фиксирует состояние и проходит валидированные опросники, специалист получает структурированную динамику, составляет план сопровождения и корректирует его по результатам очного или дистанционного контакта.

1.2. Проблемы, которые решает продукт

• За помощью нередко обращаются поздно; человеку сложно самостоятельно понять, когда нужно обратиться к специалисту.

• Между консультациями врач или психолог часто не видит регулярную динамику состояния и выполнение рекомендаций.

• Опросники, личные записи, назначения и организационные сообщения могут храниться в разных каналах.

• Пациенты пропускают домашние задания и повторные измерения; прогресс трудно оценить без единой истории.

• Руководителям организаций нужны операционные показатели работы службы при соблюдении врачебной тайны и конфиденциальности.

1.3. Целевая аудитория и ценность

Сегмент	Потребность	Ценность MindPath
Пациенты	Понятная первичная оценка, самонаблюдение, поддержка между консультациями	Один маршрут: опросники, дневник, план, результаты
Врачи-психиатры и врачи-психотерапевты	Сведения об изменениях и рисках между приёмами	Краткая структурированная динамика и история наблюдений
Психологи	Инструменты для упражнений и обратной связи	Домашние задания, дневники и отслеживание выполнения
Клиники и службы	Управление процессом сопровождения	Единый контур наблюдения, разграничение ролей и агрегированная аналитика

1.4. Границы решения

PHQ-9 и GAD-7 оценивают выраженность симптомов, но **не являются самостоятельным инструментом постановки диагноза**. Диагноз, медицинские назначения и решения об изменении лечения остаются за уполномоченным специалистом. Система должна поддерживать клинический процесс, а не выдавать себя за круглосуточную службу экстренной помощи.

2. Пользовательские роли

2.1. Ролевая модель

Роль	Интерфейс	Основная задача
Пациент	Android, iOS, Web	Скрининг, дневник, персональная программа, обратная связь
Врач-психиатр / врач-психотерапевт	Web	Клиническая оценка, контроль симптомов, план лечения
Психолог	Web	Психологическое сопровождение и упражнения
Координатор	Web	Запись, организационные контакты, статусы обращений
Администратор клиники	Web	Сотрудники, настройки, операционная аналитика
Близкий человек	Android, iOS, Web	Ограниченная поддержка с согласия пациента
Суперадминистратор	Web	Организации, безопасность, технический аудит

2.2. Пациент: функционал

Регистрация и профиль. Возрастная категория, согласия, настройки приватности, предпочтения по уведомлениям, контакты для поддержки.

Первичный скрининг. Анкета жалоб, PHQ-9, GAD-7, вопросы о сне, энергии и повседневном функционировании; объяснение результата и рекомендация о следующем шаге.

Ежедневный дневник. Самооценка настроения, тревоги, сна, энергии и активности; заметки о событиях и возможных триггерах; просмотр истории.

Персональная программа. Назначенные специалистом упражнения и материалы, дневник мыслей по КПТ, поведенческая активация, отслеживание выполнения.

Коммуникация. Запись на консультации, календарь, защищённые сообщения, дистанционные встречи при наличии такой услуги.

Прогресс. Графики по неделям и месяцам, история измерений, отчёт для специалиста, цели и выполнение задач.

Помощь и безопасность. План действий при ухудшении, контакты помощи, безопасная маршрутизация при тревожных ответах.

Опционально. Адаптивные напоминания, трекер привычек, голосовой дневник, носимые устройства, отметки о приёме назначенных препаратов.

2.3. Врач-психиатр / врач-психотерапевт

Модуль	Функционал
Рабочий стол	Пациенты, предстоящие приёмы, поручения, уведомления
Карточка пациента	Жалобы, анамнез, результаты обследований, назначения, записи визитов
Поддержка диагностики	Опросники, структура симптомов, динамика, подготовка материалов к клиническому интервью
Мониторинг	Сон, энергия, тревога, симптомы, приверженность лечению, потенциальные побочные эффекты
План лечения	Документирование и изменение назначений в пределах профессиональных полномочий
Риски	Сигналы об ухудшении, пропущенных контрольных контактах и сообщениях, требующих оценки
Приёмы и отчёты	Календарь, заметки, видеосвязь, индивидуальные отчёты

2.4. Психолог

Модуль	Функционал
Клиенты и встречи	Список клиентов, запросы, история сессий и цели работы
Психологическая оценка	Анкеты, согласованные шкалы, динамика целей без постановки медицинского диагноза
Программы и КПТ	Упражнения, дневник мыслей, работа с избеганием и саморегуляция
Домашние задания	Назначение, сроки, оценка выполнения, обратная связь
Маршрутизация	Рекомендация медицинской консультации, если ситуация выходит за рамки компетенций

2.5. Координатор

Регистрация и обработка обращений; помощь с записью; подтверждение встреч; организационные напоминания; техническая поддержка; контроль незавершённых обращений. По умолчанию координатор **не видит** содержание личного дневника, диагностические сведения и записи специалиста.

2.6. Администратор клиники

Управление подразделениями и сотрудниками; назначение ролей и прав доступа; распределение обращений; учёт загрузки специалистов; агрегированная аналитика, шаблоны опросников и программ; интеграции. Медицинские данные конкретного пациента доступны только при отдельном законном основании и назначенных полномочиях.

2.7. Близкий человек

С согласия пациента: поддерживающие напоминания, помощь с записью, получение специально разрешённых уведомлений, контакты поддержки. Пациент выбирает объём данных, получателя и срок доступа. Переписки, диагнозы и ответы на опросники не раскрываются автоматически.

2.8. Суперадминистратор

Создание организаций, управление настройками платформы, технический мониторинг, журналы доступа, восстановление работоспособности, конфигурации интеграций и тарификация. Доступ к содержимому медицинских записей техническому администратору не нужен.

3. Пользовательский путь и ключевой сценарий

3.1. Сквозной сценарий пациента

Шаг	Действие пациента	Действие системы / специалиста
1. Начало	Создаёт аккаунт и даёт необходимые согласия	Показывает назначение сервиса, права и политику доступа
2. Скрининг	Заполняет жалобы, PHQ-9 и GAD-7	Подсчитывает баллы, объясняет, что результат не является диагнозом
3. Маршрутизация	Выбирает следующий шаг	Предлагает запись / подходящий канал помощи по установленным правилам
4. Консультация	Обсуждает состояние со специалистом	Специалист оценивает результаты и утверждает план
5. Сопровождение	Ведёт дневник, выполняет упражнения	Напоминания, история, проверка домашнего задания
6. Повторная оценка	Отвечает на контрольные вопросы	Специалист сопоставляет динамику и корректирует план

3.2. Пример сценария

Пациент жалуется на постоянную тревогу и плохой сон. После заполнения анкет получает понятное объяснение результатов и возможность записаться к специалисту. Врач или психолог проводит консультацию, определяет дальнейший маршрут и согласует программу. В течение следующих недель пациент отмечает самочувствие, выполняет задания. Перед повторным визитом специалист видит изменение показателей и обсуждает его с пациентом.

3.3. Сценарии безопасности

• Потенциально опасные ответы не обрабатываются как обычный показатель настроения: запускается отдельный клинически согласованный протокол.

• Экран помощи содержит ясные действия и контакты служб, подходящих юрисдикции пользователя.

• Уведомление специалисту имеет ответственное лицо, допустимое время реакции и резервный маршрут; не следует обещать круглосуточный мониторинг без службы 24/7.

• Пациент видит, когда данные просматриваются специалистом и как действовать при срочном ухудшении.

4. Аналоги: зарубежные клинические платформы

Ниже указаны продукты, у которых опубликованы сведения о работе с медицинскими службами или клиническими программами. Заявления компаний о масштабе внедрения следует трактовать как сведения поставщика, пока не проведена отдельная независимая проверка.

4.1. Limbic Access / Limbic Care

Платформы. Web-интеграция для служб психического здоровья; мобильное сопровождение в экосистеме Limbic.

Функционал. Первичный сбор жалоб, AI-интервью, цифровая маршрутизация, сводка для терапевта, поддержка между сессиями в связанных продуктах.

Использование. Поставщик сообщает о применении в NHS Talking Therapies, о более чем 650 тыс. оценок и охвате около 45% служб NHS Talking Therapies (показатели компании, нуждаются в актуализации).

Limbic Access · О внедрении в NHS

4.2. SilverCloud by Amwell

Платформы. Web и мобильный доступ, предоставляемый организациями.

Функционал. Структурированные программы КПТ, задания, оценка симптомов, поддержка специалиста, мониторинг прогресса, подключение медицинских служб.

Использование. Опубликованы кейсы применения в NHS, в том числе Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust.

Платформа SilverCloud · Кейс внедрения

4.3. Wysa

Платформы. Android, iOS, решения для организаций.

Функционал. AI-диалог, трекер настроения, упражнения по принципам КПТ и ДБТ, рефлексия, дыхательные практики; часть B2B-программ дополнена сопровождением человека.

Использование. Массовое приложение и отдельные решения для медицинских организаций. Следует различать wellness-приложение и клинические предложения поставщика.

Сайт · Android · iOS

4.4. THIS WAY UP

Платформы. Преимущественно Web.

Функционал. Оценка симптомов, онлайн-программы КПТ, задания, анкеты, уведомления, назначение программ специалистом и отслеживание выполнения.

Использование. Австралийская клиническая программа при участии St Vincent's Hospital и UNSW; доступна пациентам и специалистам.

Сайт · Для специалистов

4.5. MindSpot Clinic

Платформы. Web, дистанционная клиническая коммуникация.

Функционал. Первичная оценка, онлайн-курсы, психологическая помощь по телефону, сопровождение и оценка результатов.

Использование. Действующая австралийская клиническая служба, связанная с Macquarie University / MQ Health.

Сайт · Программы

4.6. Вывод по клиническим платформам

Наиболее близка к основной клинической задаче связка Limbic Access (сбор жалоб и маршрутизация), SilverCloud / THIS WAY UP (структурированное сопровождение) и MindSpot (клинический процесс). Имеет смысл анализировать их модули и последовательность работы, а не только дизайн приложения.

5. Аналоги: пользовательские мобильные приложения

Продукт	Функции	Наличие / ссылки
MindDoc	Оценка симптомов, дневник настроения, история состояния, образовательные материалы	Пользовательское приложение. Android / iOS
Daylio	Быстрый дневник эмоций и привычек, статистика, экспорт	Пользовательское приложение. Android / iOS
Clarity: CBT Thought Diary	КПТ-дневник, работа с мыслями, паттерны, настроение	Пользовательское приложение. Android / iOS
Youper	AI-диалог, рефлексия, дневник, упражнения	Пользовательское приложение. Android

Что брать в качестве ориентира: у MindDoc — длительное наблюдение и обратную связь; у Daylio — короткий ежедневный сценарий; у Clarity — структуру дневника мыслей; у Youper — разговорную форму взаимодействия. Доступность в магазинах зависит от региона и может меняться.

6. Аналоги: российский рынок

Российские сервисы прежде всего показывают, как выстроены поиск специалиста, запись, оплата и дистанционная консультация. Их публичные материалы не всегда подтверждают наличие полного клинического мониторинга между приёмами.

Продукт	Заявленный функционал	Каналы / статус
Ясно	Подбор специалиста, запись, онлайн-консультации, личный кабинет	Действующий коммерческий сервис. Web · Android · iOS
Зигмунд Онлайн	Подбор психолога, онлайн-сессии, календарь, коммуникации	Действующий коммерческий сервис. Web · Android · iOS
Alter	Подбор психолога, заявки на консультации, корпоративные программы	Действующий коммерческий сервис. Web · B2B
СберЗдоровье	Запись к врачам, консультации, медицинские сервисы	Действующая телемедицинская платформа. Android

6.1. Сравнение категорий

Критерий	Клинические платформы	Мобильные дневники	РФ-сервисы консультаций
Первичный скрининг	Обычно есть	Иногда	Зависит от продукта
Динамика симптомов	Обычно есть	Часто есть	Не основной фокус
Кабинет специалиста	Важный модуль	Редко	Есть для организации сессий
Цифровые КПТ-программы	У ряда решений	Выборочно	Нужна проверка
Запись на приём	Зависит от модели	Редко	Обычно есть
Мониторинг между приёмами	Один из основных сценариев	Самонаблюдение	Зависит от сервиса
B2B-аналитика	У платформ для организаций	Как правило, нет	Операционная аналитика

Сравнение качественное, по опубликованным материалам. Отсутствие функции в таблице означает, что она не подтверждена текущим обзором, а не доказанное отсутствие в закрытых кабинетах.

6.2. Продуктовая ниша MindPath

Предполагаемая ниша — сочетание **структурированного скрининга, регулярного мониторинга и рабочего кабинета специалиста** в одном продукте для российской организации. Преимущество пока является гипотезой: его следует проверить через интервью и пилотное внедрение.

7. Открытые проекты GitHub

7.1. Curious / MindLogger (Child Mind Institute)

Экосистема для цифровых исследований и структурированного сбора данных: мобильный клиент, Web, административный кабинет, сервер. Хороший ориентир для конструктора опросников и управления программами.

Компонент	Репозиторий	Назначение
Мобильный	mindlogger-app-refactor	React Native; анкеты и активности
Web для участников	mindlogger-web-refactor	Web-интерфейс участника
Админ-панель	mindlogger-admin	Программы, пользователи, настройки
Backend	mindlogger-backend-refactor	API и обработка данных

Лицензии частей экосистемы отличаются; для использования кода в коммерческой системе нужна проверка условий каждого репозитория, включая ограничения CPAL / DOSA, если они применимы.

7.2. mindLAMP (BIDMC Digital Psychiatry)

Исследовательская платформа цифровой психиатрии: опросники и цифровые активности, сбор данных, сервер и кабинет визуализации.

• LAMP-dashboard — интерфейс и аналитика

• LAMP-server — серверная инфраструктура

• LAMP-activities — активности и упражнения

• Документация — архитектура и API

Для mindLAMP особенно важно проверять лицензию конкретной версии: у отдельных компонентов условия менялись.

7.3. RADAR-base

RADAR-Questionnaire. гибридный клиент на Ionic / Angular / Capacitor для опросников и уведомлений; Android и iOS. Технически близок к модулю скрининга.

radar-prmt-android. Android-приложение для пассивного сбора данных и удалённого мониторинга. Для MindPath возможно только как поздний, отдельно обоснованный модуль.

7.4. Empathibot / MindCare

GitHub: Empathibot. небольшой открытый демопроект. Автор заявляет PHQ-9, GAD-7, AI-анализ ответов, панель аналитики и интеграцию с чатботом. Можно изучить прототипирование, но не использовать как доказательство медицинской безопасности.

7.5. Что использовать в разработке

Потребность	Приоритетный ориентир
Полный контур mobile + Web + backend	Curious / MindLogger
Исследовательский мониторинг и визуализация	mindLAMP
Конструктор опросников	RADAR-Questionnaire
Данные смартфона и носимых устройств	RADAR-base
Быстрый тематический демонстратор	Empathibot (только для изучения)

8. MVP и дорожная карта

8.1. Функциональная приоритизация

Функциональный блок	Этап	Цель
Регистрация, согласия, права доступа	MVP	Безопасный старт
PHQ-9 / GAD-7 и история ответов	MVP	Первичная структурированная оценка
Ежедневный дневник и графики	MVP	Динамика между консультациями
Web-кабинет специалиста и карточка	MVP	Просмотр состояния пациента
Простые упражнения и выполнение задач	MVP	План сопровождения
Базовая маршрутизация при рисках	MVP	Безопасность пользователя
Полная библиотека КПТ-материалов	Релиз 2	Развитие программ
Чат, календарь и видеоконсультации	Релиз 2	Коммуникация
Кабинет руководителя и отчётность	Релиз 2	B2B-управление
AI-сводка динамики под контролем специалиста	Позднее	Снижение рутины
Интеграции с МИС и носимыми устройствами	Позднее	Встраивание в экосистему

8.2. Основные экраны первой версии

Пациент — Android / iOS / Web	Специалист — Web
Главная / как я себя чувствую	Главная панель
Прохождение опросника	Реестр пациентов
Результаты скрининга	Карточка пациента
Дневник настроения	Динамика симптомов
Персональная программа	План сопровождения
История и прогресс	Библиотека упражнений
Помощь и безопасность	Уведомления и задачи

8.3. Пример карточки пациента (вымышленные данные)

Показатель	Текущее значение	Предыдущее	Комментарий
PHQ-9	14	17	Изменения оценивает специалист
GAD-7	11	13	Требует клинической интерпретации
Дневник	6 из 7 дней	—	Активность за неделю
Домашние задания	1 выполнено, 1 открыто	—	Запланировать обсуждение

На экране дополнительно отображаются даты заполнения шкал, графики значений, комментарии пациента, назначения специалиста, сведения о пропусках и история корректировок плана. Снижение баллов не должно автоматически приводить к изменению терапии.

8.4. Предлагаемые этапы запуска

• **Discovery:** интервью, клинические сценарии, карта рисков, предварительные требования к данным.

• **Прототип:** интерактивные экраны пациента и специалиста; тестирование понятности и нагрузки.

• **Технический MVP:** скрининг, дневник, история, кабинет, базовые права доступа и журналирование.

• **Закрытый пилот:** небольшая группа специалистов и пациентов, согласованные критерии безопасности и эффективности процесса.

• **Доработка:** работа с выявленными проблемами и решение о расширении функций и масштаба.

9. Техническая архитектура

9.1. Технологический стек

Уровень	Предложение	Назначение
Web	React, TypeScript, MUI	Кабинеты специалистов и организации
Мобильные приложения	React Native, TypeScript	Android и iOS с общей кодовой базой
Backend	Python, FastAPI	REST API и бизнес-логика
БД	PostgreSQL	Пользователи, опросники, наблюдения, назначения
Очереди	Redis + Celery	Уведомления и фоновые задачи
Графики	Recharts	Отображение динамики в Web
Авторизация	OIDC / OAuth 2.0, RBAC	Разделение доступа
Инфраструктура	Docker, CI/CD	Развёртывание и тестирование

9.2. Логические модули backend

auth / consents. Авторизация, роли, согласия и права.

patients / practitioners. Профили пациентов, специалистов, организаций.

screening. Версии опросников, ответы, проверяемый расчёт баллов.

monitoring. Дневник, временные ряды, отчёты.

care_plans. Программы и назначения заданий.

appointments / messaging. Запись и коммуникации после включения в релиз.

notifications / safety. Напоминания и управляемые сценарии реагирования.

audit. События доступа и изменения чувствительных данных.

9.3. Основные сущности

Organization, **User**, **PatientProfile**, **PractitionerProfile**, **Questionnaire**, **QuestionnaireVersion**, **Assessment**, **AssessmentAnswer**, **MoodEntry**, **CarePlan**, **CareTask**, **Appointment**, **Consent**, **AuditEvent**.

9.4. Использование AI

На старте достаточно детерминированных правил подсчёта шкал, графиков и явных условий уведомлений. AI-модули можно рассмотреть для черновиков сводок врачу и навигации по материалам. Выводы AI не должны автоматически становиться диагнозом, назначением или самостоятельной кризисной рекомендацией.

10. Клинические, правовые и этические требования

10.1. Безопасность пациентов

• Подтвердить права на применение версий диагностических шкал, требования к переводу и интерпретации; сохранять исходные ответы и версию инструмента.

• Утвердить совместно с клиницистами протокол работы с потенциально опасными ответами, порядок дополнительной оценки и маршрутизации.

• Не создавать ожидания круглосуточного наблюдения, если у сервиса нет соответствующей команды и регламента.

• Указывать, что результаты цифрового скрининга не равны клиническому диагнозу.

• Тестировать не только удобство интерфейса, но и вероятность пропуска/неверной трактовки опасных событий.

10.2. Работа с данными

Для запуска в РФ необходимо проектировать обработку сведений о здоровье с учётом Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», требований безопасности и локализации применительно к выбранной архитектуре. Доступ специалиста, администратора и близкого человека должен быть строго разграничен. В продукте необходимы аудит доступа, правила хранения и удаления данных, управление согласиями и защищённые каналы обмена.

10.3. Медицинский статус ПО

Назначение продукта влияет на его регуляторный статус. Если ПО заявляет диагностику заболеваний, медицинские рекомендации или клинические решения, до запуска требуется профильная юридическая и регуляторная оценка необходимости регистрации медицинского изделия и иных требований. Наличие PHQ-9/GAD-7 как формы ввода само по себе вопрос не решает.

10.4. Организация клинической работы

Нужно отдельно описать: кто просматривает результаты; когда проводится повторный контакт; что делать с пропущенными сообщениями; как работает передача пациента специалисту; кто отвечает за уведомления; как документируется клиническое решение. Эти правила важнее сложных AI-функций на первом этапе.

11. Бизнес-модель, метрики и проверка гипотез

11.1. Предполагаемые заказчики

Первый приоритет — частные клиники психического здоровья и центры, где есть регулярные повторные консультации. Следующие сегменты: психологические службы университетов, корпоративные программы поддержки сотрудников, сети медицинских центров. Для немедицинских организаций необходимо отдельно определить границы диагностического функционала.

11.2. Возможная монетизация

Подписка для организации: по числу активных специалистов либо сопровождаемых пациентов; дополнительные модули для расширенной аналитики или интеграций. Конкретные цены пока не определяются: необходимы интервью с ЛПР, анализ затрат на безопасность и клинические операции, а также оценка готовности платить.

11.3. KPI продукта

Метрика	Что измеряет
Screening Completion Rate	Доля завершённых первичных скринингов
Activation Rate	Доля зарегистрированных, начавших наблюдение
Weekly Check-in Rate	Регулярность дневниковых отметок
Follow-up Completion	Прохождение контрольных измерений в срок
Care Plan Adherence	Выполнение согласованных заданий
Clinician Time per Patient	Время специалиста на подготовку к приёму
Alert Acknowledgement Time	Время принятия в работу уведомлений
Clinic Adoption Rate	Доля активно использующих платформу специалистов

Результаты PHQ-9/GAD-7 могут быть одним из показателей наблюдения, но не являются самостоятельным доказательством эффективности продукта или лечения.

11.4. План Discovery

Кого интервьюировать	Количество (ориентир)	Что проверить
Психиатры / врачи-психотерапевты	5–7	Наблюдение между приёмами, клиническая польза, риски
Психологи	5–7	Упражнения, дневники, обратная связь, рабочая нагрузка
Потенциальные пациенты	8–10	Понятность анкеты, время на записи, мотивация
Руководители клиник	2–3	Интеграции, бюджет, соответствие требованиям, внедрение

11.5. Ключевые продуктовые гипотезы

• **H1:** пациент готов отмечать самочувствие несколько раз в неделю, если видит смысл и не сталкивается с избыточными вопросами.

• **H2:** структурированная история снижает время специалиста на подготовку к повторной встрече.

• **H3:** возможность назначать упражнения в той же системе повышает прозрачность выполнения плана.

• **H4:** клиника видит ценность в мониторинге между консультациями и готова выделить людей на работу с уведомлениями.

12. Итоговая рекомендация

Разрабатывать **MindPath как платформу непрерывного сопровождения** с двумя центральными сценариями: пациент отслеживает состояние и выполняет согласованную программу; специалист получает историю наблюдений, проводит оценку и управляет планом. Такой MVP имеет ясную прикладную ценность и не требует сразу строить универсальную AI-систему.

Для изучения рынка приоритетны Limbic Access, SilverCloud, THIS WAY UP и MindDoc. Для технического исследования — Curious / MindLogger и mindLAMP. Следующий практический шаг — подтвердить сценарий 1–2 клиниками, разработать интерактивный прототип, определить обязательные требования к безопасности и

лишь затем переходить к разработке полного функционала.

Приложение. Основные ссылки и материалы

A. Продукты и внедрения

- Limbic Access
- Limbic в NHS Talking Therapies
- SilverCloud
- Wysa
- THIS WAY UP
- THIS WAY UP для клиницистов
- MindSpot Clinic
- Ясно
- Зигмунд Онлайн
- Alter

Б. Исходный код и документация

- MindLogger — мобильное приложение
- MindLogger — Web
- MindLogger — администратор
- MindLogger — backend
- mindLAMP dashboard
- mindLAMP server
- mindLAMP activities
- mindLAMP documentation
- RADAR-Questionnaire
- RADAR Android
- Empathibot

B. Ориентиры по безопасности и нормативным вопросам

- NICE: Depression in adults — NG222
- NIMH: Suicide Risk Screening Pathway
- Федеральный закон № 152-ФЗ (официальная публикация)
- Росздравнадзор

Ссылки приведены как источники для дальнейшей проверки. Описание функций и внедрений сформировано по открытым материалам; даты, региональная доступность приложений, лицензии и регуляторные статусы необходимо перепроверять перед официальной публикацией или внедрением.